

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

OPINIA PRZEDSZKOLA / SZKOŁY · DLA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO · DLA RODZICA

OCENA FUNKCJONALNA · ICF · PRZEDSZKOLE · SZKOŁA

Raport Oceny Funkcjonalnej

OBSERWACJA WSTĘPNA I POGŁĘBIONA · OBSZARY ICF

z dnia _____

OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ W SKŁADZIE

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 6. _____ |

§

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (**Dz. U. z 2026 r. poz. 428**), a w szczególności wchodzącymi w życie z dniem 1 września 2026 r. przepisami **§ 7 ust. 6 i ust. 7**, opinia przedszkola/szkoły wydawana dla zespołu poradni (i przekazywana rodzicowi) musi mieć ściśle określoną strukturę opartą na obszarach ICF: odrębnych dla dziecka w wieku przedszkolnym oraz dla ucznia szkoły.

■ CZĘŚĆ I · PODSTAWA, METRYCZKA I NARZĘDZIA

1

Metryczka bazowa

dane dziecka, wariant wsparcia, podstawa formalna, zdrowie

2

Obserwacja wstępna

procedura wrzeźniowej obserwacji w obszarach ICF

3

Obserwacja pogłębiona

wskazania i narzędzia: ABC, biopsychospołeczny, sensoryczny, mowa, ToM

■ CZĘŚĆ II · WYNIKI OCENY FUNKCJONALNEJ

4

Funkcjonowanie w placówce

5

Wyniki liczbowe KPOF / KSzOF

6

Wyniki arkuszy specjalistycznych

7

Mój głos – perspektywa dziecka

8

Działania dotychczas podjęte

9

Analiza jakościowa 9 domen ICF

10

Decyzja Zespołu: poziom wsparcia

■ CZĘŚĆ III · PROGRAM WSPARCIA I ORGANIZACJA

11

Dostosowanie programu, organizacji i technologii

12

Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów

13

Zajęcia: rewalidacja, PPP, zalecenia poradni

14

Uzasadnienie wsparcia dodatkowej osoby

15

Współpraca z rodzicami i poradnią

16

Terminy oceny efektywności · podpisy

ICF

KSzOF

ABC

Profil Sensoryczny

AAC

ToM

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

1 METRYCZKA BAZOWA

IMIĘ I NAZWISKO	[Imię i Nazwisko dziecka / ucznia]
DATA URODZENIA	[Data urodzenia]
PLACÓWKA / ODDZIAŁ	[Nazwa przedszkola / szkoły, grupa / klasa]
WARIANT WSPARCIA	☐ Wariant A – wsparcie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ☐ Wariant B – wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (bez orzeczenia)
JEDNOSTKA / PODSTAWA FORMALNA	Na podstawie dołączonego dokumentu: [Orzeczenie / Opinia] nr [Numer] z dnia [Data], wydanego przez: [Nazwa Poradni], z uwagi na: [np. autyzm, w tym zespół Aspergera / niepełnosprawność ruchowa / inne]
SCHOROZENIA PRZEWLEKŁE	☐ Brak ☐ Występują: [np. cukrzyca, astma, epilepsja]
FARMAKOTERAPIA I WSKAZANIA LEKARZA	Zgodnie ze wskazaniami lekarza dziecko/uczeń stale / doraźnie przyjmuje leki: [Nazwa leków, zalecenia postępowania / Nie dotyczy]

2 PODSTAWA I PROCEDURA OBSERWACJI WSTĘPNEJ

1 Zgłoszenie zgłaszane trudności w funkcjonowaniu oraz wniosek rodzica	2 Dokumentacja posiadana opinia / orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej	3 Obserwacja · wrzesień Kwestionariusz Przedszkolnej / Szkolnej Oceny Funkcjonalnej	4 Analiza ICF obszary zgodne z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania
--	---	---	---

Z uwagi na zgłaszane trudności w funkcjonowaniu, wniosek rodzica oraz posiadaną dokumentację (w tym opinię/orzeczenie poradni), w placówce przeprowadzono **we wrześniu** obserwację poziomu funkcjonowania z wykorzystaniem **Kwestionariusza Przedszkolnej / Szkolnej Oceny Funkcjonalnej**, analizującego funkcjonowanie w obszarach zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Funkcje ciała
bStruktury ciała
sAktywność i
uczestnictwo
dCzynniki środowiskowe
eCzynniki osobowe
—

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

3 WSKAZANIA DO OBSERWACJI POGŁĘBIONEJ I ZASTOSOWANE NARZĘDZIA

W związku ze zidentyfikowanymi w toku oceny wstępnej trudnościami w funkcjonowaniu – w szczególności w zakresie **trudnych zachowań, rozwoju funkcji poznawczych, przetwarzania bodźców** oraz **komunikacji** – przeprowadzono obserwację pogłębioną z wykorzystaniem następujących narzędzi specjalistycznych:

ZACHOWANIA TRUDNE

Arkusze Obserwacji Behawioralnej ABC

Zastosowany z uwagi na występowanie zachowań trudnych – identyfikacja bodźców wywołujących, formy zachowania oraz funkcji i skutków podtrzymujących.

A

bodźce wywołujące

B

forma zachowania

C

funkcja i skutki podtrzymujące

CAŁOŚCIOWY OBRAZ

Profil Biopsychospołeczny

Ujęcie funkcjonowania dziecka w wymiarze biologicznym, psychologicznym i społecznym – zgodnie z modelem ICF.

PRZETWARZANIE BODŹCÓW

Profil Sensoryczny

Ocena reaktywności sensorycznej (nadwrażliwości, podwrażliwości, poszukiwania stymulacji) i wpływu bodźców środowiskowych na dysregulację dziecka.

KOMUNIKACJA

Arkusze Oceny Rozwoju Mowy i Komunikacji

Zastosowany w związku ze specyficznymi trudnościami w nadawaniu i rozumieniu mowy, echolaliami lub potrzebą wdrożenia / rozwijania AAC.

FUNKCJE POZNAWCZE I SPOŁECZNE

Arkusze Poziomu Rozwoju Teorii Umysłu (ToM)

Zbadanie poziomu rozumienia stanów mentalnych, intencji, perspektywy i emocji innych osób w sytuacjach społecznych.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

RAPORT OCENY FUNKCJONALNEJ DZIECKA / UCZNIA · CZĘŚĆ II

Wyniki oceny funkcjonalnej

OBSERWACJA W PLACÓWCE · WYNIKI LICZBOWE · ARKUSZE SPECJALISTYCZNE · GŁOS DZIECKA · ANALIZA ·
DECYZJA ZESPOŁU4 INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU W PLACÓWCE – TRUDNOŚCI, MOCNE STRONY I
UZDOLNIENIA

§ 7 ust. 6 pkt 3. Syntetyczne zestawienie potencjału rozwojowego oraz barier zidentyfikowanych w toku codziennej aktywności przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/ucznem:

OBSZAR OBSERWACJI	✓ MOCNE STRONY, ZASOBY I UZDOLNIENIA	► TRUDNOŚCI, OGRANICZENIA I BARIERY
Aktywność poznawcza i uczenie się	Bardzo dobra pamięć wzrokowa; szybkie zapamiętywanie schematów graficznych; wąskie, ale głębokie zainteresowania tematyczne; wysoka motywacja do pracy z ulubionymi pomocami dydaktycznymi.	Trudności z przerzutnością i podzielnością uwagi; szybka męczliwość przy instrukcjach wieloetapowych; problem z uogólnianiem (generalizacją) wiedzy; wymagane stałe tempo i pomoce wizualne.
Komunikacja i porozumiewanie się	Prawidłowe rozumienie prostych, jednoznacznych komunikatów słownych wspartych gestem; sygnalizowanie podstawowych potrzeb fizjologicznych.	Dosłowne rozumienie wypowiedzi (trudność z metaforą i żartem); echolalie odroczone; trudności w inicjowaniu dialogu i naprężeniu wypowiedzi w grupie rówieśniczej; potrzeba wsparcia AAC.
Relacje społeczne i emocje	Chęć przebywania w pobliżu grupy; pozytywna reakcja na stałych, przewidywalnych dorosłych; przestrzeganie czytelnych zasad wizualnych.	Trudności w odczytywaniu emocji i intencji innych (słaba teoria umysłu); niska tolerancja frustracji w sytuacjach przegranej lub nagłej zmiany; tendencja do wycofywania się lub zachowań trudnych.
Motoryka i sprawność fizyczna	Sprawność w zakresie motoryki dużej (bieganie, wspinanie się); chętnie uczestnictwo w zabawach ruchowych w otwartej przestrzeni.	Obniżona precyzja motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; nieprawidłowy chwyt pisarski / narzędzi; wzmożone lub obniżone napięcie posturalne; męczliwość ręki wiodącej.
Samoobsługa i autonomia	Samodzielność w zakresie podstawowych nawyków higienicznych i toaletowych; znajomość własnej szafki i osobistych przyborów.	Opór sensoryczny przy myciu rąk (wrażliwość na fakturę mydła/wodę); wybiórczość pokarmowa; problem z ubieraniem odzieży wierzchniej ze skomplikowanymi zapięciami; potrzeba nadzoru dorosłego.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

5 AKTUALNA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA – WYNIKI LICZBOWE

§ 7 ust. 6 pkt 4. Zestawienie parametrów ilościowych uzyskanych z narzędzia bazowego (KPOF dla przedszkola / KSzOF dla szkoły) w 9 obszarach Międzynarodowej Klasyfikacji ICF:

NARZĘDZIE BAZOWE

☐ Przedszkole · KPOF · bez stenów☒ Szkoła · KSzOF · ze stenami

NARZĘDZIE BAZOWE

KSzOF szkoła

PUNKTY SUROWE

68 / 180 pkt

ŚREDNIA

Śr: 2,1 w skali 0–5

OGÓLNY POZIOM WSPARCIA

Poziom 2

(Umiarkowany)

KOD	DOMENA ICF	PUNKTY / ŚR.	STEN (KSZOF)	POZIOM WSPARCIA	WSKAŹNIK FUNKCJONALNY
d1	Uczenie się i stosowanie wiedzy	Śr: 2,4 (12 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Wymaga podziału zadań na etapy i wsparcia wizualnego.
d2	Ogólne zadania i wymagania	Śr: 1,8 (9 pkt)	Sten 3	Poziom 3 · Wysoki	Brak elastyczności, silny stres przy nagłych zmianach.
d3	Komunikacja i porozumiewanie się	Śr: 2,0 (10 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Echolalie, konieczność wdrażania schematów AAC.
d4	Poruszanie się i motoryka	Śr: 3,2 (16 pkt)	Sten 6	Poziom 1 · Niski	Ogólna motoryka dobra; obniżona grafomotoryka.
d5	Dbanie o siebie i samoobsługa	Śr: 2,2 (11 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Wybiórczość sensoryczna przy posiłkach i toalecie.
d6	Życie domowe / Obowiązki placówki	Śr: 2,8 (14 pkt)	Sten 5	Poziom 1 · Niski	Sprząta kącik zabaw po bezpośrednim przypomnieniu.
d7	Relacje i kontakty międzyludzkie	Śr: 1,6 (8 pkt)	Sten 3	Poziom 3 · Wysoki	Bariery w interakcjach rówieśniczych, konflikty, wycofanie.
d8	Główne dziedziny życia (Edukacja)	Śr: 2,0 (10 pkt)	Sten 4	Poziom 2 · Średni	Wymaga dostosowania metod i stałego nadzoru nauczyciela.
d9	Życie społecznościowe i obywatelskie	Śr: 1,8 (9 pkt)	Sten 3	Poziom 3 · Wysoki	Trudność w uczestnictwie w apelach i wyjściach zbiorowych.

Pasek: Średnia w skali 0–5

Poziom 1 · Niski

Poziom 2 · Średni

Poziom 3 · Wysoki

Zasada: wybrano KSzOF (szkoła) – sten-y podaje się wyłącznie w kolumnie „Sten” dla poszczególnych domen; średniej nigdy nie opisuje się stenem.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

6 WYNIKI OBSERWACJI POGLĘBIONEJ (NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE)**Arkusz Obserwacji Behawioralnej ABC**

Zidentyfikowano **14 epizodów** zachowań trudnych. **Bodźce wyzwalające (A)**: trudne polecenia pisemne, hałas, niespodziewane przejścia między aktywnościami. **Topografia zachowania (B)**: głośny krzyk, odmowa zejścia z dywanu, odpychanie kart pracy. **Funkcja (C)**: ucieczka przed przeciążeniem sensorycznym / zadaniem trudnym poznawczo.

Zalecenie: protokół wyprzedzający i nauka komunikatu zastępczego.

Profil Sensoryczny (Kwestionariusz Przetwarzania)

Reaktywność mieszana. **Układ słuchowy** – silna nadwrażliwość na nagłe dźwięki i gwar korytarza (zalecane słuchawki); **układ dotykowy** – obronność dotykowa na faktury klejące i mokre; **układ proprioceptywny i przedsionkowy** – poszukiwanie stymulacji dociskowej i ruchowej (huśtanie, kołysanie się).

Profil Biopsychospołeczny

Uwarunkowania biologiczne: spektrum autyzmu, zaburzenia snu wpływają na zmęczenie poranne. **Uwarunkowania psychologiczne**: silny lęk przed zmianą schematu, sztywność poznawcza. **Czynniki środowiskowe**: wysokie zaangażowanie rodziny, pozytywna reakcja na stałą kadrę.

Arkusz Oceny Rozwoju Mowy i Komunikacji

Zasób słownika biernego w normie wiekowej; wąski zasób czynny w sytuacjach swobodnych. Występują **echolalie natychmiastowe** i trudności pragmatyczne (brak intonacji, trudność w podtrzymaniu dialogu).

Zalecenie: schematy dialogowe i piktogramy wspierające.

Arkusz Poziomu Rozwoju Teorii Umysłu (ToM)

Poziom rozwoju ToM **poniżej normy wiekowej**. Trudność w zadaniach z fałszywym przekonaniem (False Belief Task) oraz w rozpoznawaniu perspektywy i intencji innych osób. Trudności te generują konflikty rówieśnicze przez błędną interpretację zachowań kolegów.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

7 MÓJ GŁOS – PERSPEKTYWA DZIECKA / UCZNIA

Głos dziecka pozyskano w sposób dostosowany do jego możliwości komunikacyjnych: w naturalnych sytuacjach, przez proste pytania, obrazki, piktogramy i informacje od rodziców. Zapisano autentyczną perspektywę dziecka – jego słowami lub przez wskazanie.

SPOSÓB POZYSKANIA GŁOSU DZIECKA – ZAZNACZONO

- | | |
|--|---|
| ☒ Rozmowa dostosowana do możliwości dziecka | ☒ Obserwacja w naturalnych sytuacjach |
| ☒ Wybór z obrazków / piktogramów / kart wyboru | ☒ Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) |
| ☐ Odczytanie z gestu, mimiki, zabawy, rysunku | ☒ Informacje od rodziców / opiekunów |
| ☒ Skala buziek / termometr emocji | ☐ Wskazanie „tak / nie” na symbolach |

MOJE MOCNE STRONY I SUPERMOCE

„Umiem układać klocki i znam wszystkie planety. Pamiętam, gdzie co leży.”

Z CZYM MAM NAJWIĘKSZĄ TRUDNOŚĆ W PRZEDSZKOLU / SZKOLE

„Jak jest głośno i jak pani zmienia plan. Nie lubię mokrych rąk i kleju.”

MOJE ULUBIONE ZABAWY I CZYNNOŚCI

klocki konstrukcyjne, tablet z aplikacją o kosmosie, huśtanie się, oglądanie map

MOJE MARZENIE / CZEGO BYM CHCIAŁ(A)

„Żeby kolega bawił się ze mną w rakiety i żeby nie było apeli.”

CO MI NAJBARDZIEJ POMAGA – ZAZNACZONO

- | | |
|--|---|
| ☒ cisza | ☒ czas |
| ☒ ruch | ☒ piktogramy |
| ☒ praca na komputerze / tablecie | ☒ przerwy |
| ☒ wsparcie nauczyciela | ☒ przewidywalny plan dnia |
| ☒ słuchawki | ☐ moje własne miejsce |

JAK SIĘ DZIŚ CZUJĘ – WSKAZANIE DZIECKA



PREFEROWANY SPOSÓB KOMUNIKACJI DZIECKA I WSKAZÓWKI DO ROZMOWY

Mowa proste zdania + tablica wyboru (piktogramy); rozumie polecenia wsparte gestem; potrzebuje chwili na odpowiedź; nie lubi pytań „dlaczego”. Wskazówki do rozmowy: jedno pytanie na raz, obrazek lub wybór z dwóch, bez metafor i żartów.

Podstawa. Uwzględnienie perspektywy dziecka wspiera indywidualizację i podmiotowe traktowanie zgodnie z modelem ICF. „Mój głos” to element nowego modelu 2026/27.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

8 INFORMACJA O DZIAŁANIACH DOTYCHCZAS PODJĘTYCH W CELU POPRAWY FUNKCJONOWANIA

§ 7 ust. 6 pkt 6. Działania wdrożone w placówce przed sporządzeniem raportu oraz ich obserwowana efektywność (podstawa do zaplanowania programu wsparcia w Części III):

RODZAJ WSPARCIA	ZAKRES WDROŻONYCH DZIAŁAŃ I METODY	EFEKTYWNOŚĆ I OBSERWOWANE ZMIANY
Dostosowania środowiskowe i dydaktyczne	Wyznaczenie strefy wyciszenia w sali; zredukowanie bodźców wzrokowych na tablicach ściennych; zastosowanie słuchawek wygłuszających podczas pracy stolikowej; wprowadzenie indywidualnego planu dnia na rzepy.	Spadek liczby epizodów trudnych zachowań o ok. 40%; wydłużenie czasu skupienia na pojedynczym zadaniu z 3 do 8 minut.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja	Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (TUS – 1x w tyg.); indywidualne zajęcia logopedyczne (1x w tyg.); ćwiczenia integracji sensorycznej (SI) na sali gimnastycznej.	Lepsze tolerowanie obecności innych dzieci w trakcie zajęć kierowanych; pierwsze próby proszenia o przerwę za pomocą gestu/piktogramu.
Współpraca z domem rodzinnym	Cotygodniowe konsultacje z rodzicami; zeszyt korespondencji dom-placówka; ujednolicenie systemu komunikatów i nagród behawioralnych.	Wysoka spójność w reakcjach dorosłych na zachowania trudne; wzrost poczucia bezpieczeństwa u dziecka.

Informacja dla rodzica. Wyniki z sekcji 4–8 są podstawą analizy (sekcja 9) i decyzji Zespołu o poziomie wsparcia (sekcja 10). Część III opisuje, jak placówka zorganizuje wsparcie w tym roku szkolnym.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

9 ANALIZA JAKOŚCIOWA OBSZARÓW OBSERWACJI ORAZ KIERUNKI PRACY W IPE

Szczegółowa diagnoza funkcjonalna we wszystkich 9 domenach ICF. Kolumna „Kierunki pracy” wskazuje cele i metody; ich organizację (kto, kiedy, ile) opisuje Część III.

DOMENA ICF	OPIS FUNKCJONOWANIA I BARIERY	KIERUNKI PRACY W IPE (METODY / DOSTOSOWANIA)
Uczenie się i stosowanie wiedzy d1	Dziecko/uczeń przyswaja wiedzę głównie kanałem wzrokowym. Występuje trudność w rozumieniu poleceń złożonych oraz w transferze (uogólnianiu) wiedzy. Przebodźcowanie powoduje dekoncentrację i rezygnację z zadania.	- Plany aktywności w formie piktogramów / checklist. - Dzielenie instrukcji na pojedyncze, sekwencyjne kroki. - Wydłużenie czasu na realizację zadań pisemnych i wykonawczych.
Ogólne zadania i wymagania d2	Trudność w samodzielnej organizacji pracy i realizacji zadań wieloetapowych. Brak elastyczności – silny stres przy nagłych zmianach planu i przejściach między aktywnościami.	- Stały, wizualny plan dnia i zapowiadanie zmian z wyprzedzeniem. - Pomoce sensoryczne do orientacji w czasie (stoper, zegar time-timer). - Protokół wyprzedzający przed trudnymi przejściami.
Komunikacja i porozumiewanie się d3	Wypowiedzi cechują się trudnościami pragmatycznymi, obecnością echolalii oraz dosłownością interpretacji. W chwilach przeciążenia emocjonalnego następuje mutyzm wybiórczy lub krzyk zamiast komunikacji intencjonalnej.	- Tablice wyboru i skrypty dialogowe AAC. - Unikanie metafor, sarkazmu i dwuznaczności w komunikatach personelu. - Trening komunikacji funkcjonalnej (FCT: „chcę przerwać”, „nie rozumiem”). - Terapia logopedyczna/neurologopedyczna.
Poruszanie się i motoryka d4	Motoryka duża prawidłowa (bieganie, wspinanie). Obniżona precyzja motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i planowania motorycznego (dyspraksja); nieprawidłowy chwyt pisarski i narzędzi.	- Dostosowanie przyborów (nakładki ergonomiczne na ołówki, nożyczki sprężynowe). - Ćwiczenia rewalidacyjne ukierunkowane na motorykę małą i dużą. - Ćwiczenia integracji sensorycznej (SI).
Dbanie o siebie i samoobsługa d5	Samoobsługa zaburzona przez silne reakcje nadwrażliwości na bodźce dotykowe (ubrania, mokre ręce) i zapachowe; wybiórczość pokarmowa; trudność z odzieżą o skomplikowanych zapięciach.	- Stała kolejność czynności toaletowych wsparta paskiem wizualnym. - Stopniowe osvajanie faktur i zapachów w bezpiecznych warunkach. - Odzież bez trudnych zapięć; nadzór dorosłego przy posiłkach.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

9 ANALIZA JAKOŚCIOWA OBSZARÓW OBSERWACJI ORAZ KIERUNKI PRACY W IPE · CD.

DOMENA ICF	OPIS FUNKCJONOWANIA I BARIERY	KIERUNKI PRACY W IPE (METODY / DOSTOSOWANIA)
Życie domowe / Obowiązki placówki d6	Wykonuje obowiązki grupowe (sprzątanie kąpka zabaw, dyżury) po bezpośrednim przypomnieniu. Trudność w samodzielnym inicjowaniu czynności i doprowadzaniu ich do końca.	- Lista zadań na rzepy z odhaczaniem wykonanych czynności. - Stałe dyżury z modelowaniem przez dorosłego. - Wzmocnienia pozytywne (pochwała opisowa, system żetonowy).
Relacje i kontakty międzyludzkie d7	Trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu zabawy naprzemiennej. Brak umiejętności rozpoznawania sygnałów niewerbalnych wysyłanych przez rówieśników. Częste nieporozumienia prowadzące do zachowań oporowych.	- Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w małej grupie. - Historyjki Społeczne (Social Stories) modelujące zachowania prospołeczne. - Rówieśnik-mentor w zabawach grupowych. - Jasne, wizualne zasady panujące w klasie/grupie.
Główne dziedziny życia (Edukacja) d8	Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych wymaga dostosowania metod, tempa i form pracy oraz stałego nadzoru nauczyciela. Szybka męczliwość przy zadaniach pisemnych i instrukcjach wieloetapowych.	- Dostosowane karty pracy (mniej bodźców, większa czcionka, jedno polecenie na raz). - Wsparcie nauczyciela współorganizującego w zadaniach kierowanych. - Przerwy sensoryczne wpisane w plan zajęć.
Życie społecznościowe i obywatelskie d9	Trudność w uczestnictwie w apelach, uroczystościach i wyjściach zbiorowych z powodu przeciążenia sensorycznego i tłumy – wycofanie lub zachowania trudne.	- Wcześniejsze przygotowanie (historyjka społeczna, zdjęcia miejsca, plan wydarzenia). - Słuchawki wygłaszające i miejsce z możliwością wyjścia. - Stopniowe wydłużanie czasu udziału w wydarzeniach grupowych.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

10 USTALENIE DECYZJĄ ZESPOŁU POZIOMU WSPARCIA DLA DZIECKA / UCZNIA _____

Na podstawie wyników KPOF/KSzOF (sekcja 5), arkuszy specjalistycznych (sekcja 6), głosu dziecka (sekcja 7), dotychczasowych działań (sekcja 8) oraz zaleceń poradni Zespół ustala poziom wsparcia:

☐ **Poziom I – niski**

wsparcie w ramach bieżącej pracy nauczyciela i dostosowań;
monitorowanie

☒ **Poziom II – umiarkowany**

dostosowania + zajęcia specjalistyczne i rewalidacja; wsparcie dodatkowej osoby w wybranych sytuacjach

☐ **Poziom III – wysoki**

intensywne, codzienne wsparcie specjalistyczne i stała obecność dodatkowej osoby

UZASADNIENIE DECYZJI ZESPOŁU

Średnia funkcjonowania 2,1 (68/180 pkt) z trzema domenami na poziomie wysokim (d2, d7, d9) i czterema na poziomie średnim. Zachowania trudne (14 epizodów wg ABC) mają funkcję ucieczkową i są kontrolowalne przy dostosowaniu środowiska – po wdrożonych działaniach spadły o ok. 40%. Dziecko dobrze reaguje na strukturę i stałą kadrę, co uzasadnia poziom II z wsparciem dodatkowej osoby w zajęciach kierowanych i przejściach (sekcja 14), a nie stałą obecnością.

REWALIDACJA**2 godz. / tydz.****POMOC
PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA****3 godz. 30 min / tydz.****DODATKOWA OSOBA****nauczyciel
współorganizujący –
zajęcia kierowane****OCENA EFEKTYWNOŚCI****styczeń i czerwiec
(sekcja 16)**

Data posiedzenia Zespołu: [Data posiedzenia Zespołu] · Rodzic uczestniczył w posiedzeniu Zespołu i otrzymał kopię raportu. · **Podpisy**
Zespołu i rodzica: na końcu dokumentu (sekcja 16).

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

RAPORT OCENY FUNKCJONALNEJ DZIECKA / UCZNIA · CZĘŚĆ III

Program wsparcia i organizacja

DOSTOSOWANIA · ZINTEGROWANE DZIAŁANIA · ZAJĘCIA · DODATKOWA OSOBA · RODZICE I PORADNIA · OCENA
EFEKTYWNOŚCI11 ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA PROGRAMU, ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA I
TECHNOLOGII

Dostosowania wynikają z analizy jakościowej (sekcja 9) i decyzji o poziomie wsparcia (sekcja 10). Dotyczą: programu wychowania przedszkolnego | podstawy programowej kształcenia ogólnego (szkoła).

A Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego / podstawy programowej

ZAKRES	SPOSÓB DOSTOSOWANIA
Cele i treści	Cele realizowane w pełnym zakresie podstawy; treści dzielone na mniejsze kroki, priorytet dla umiejętności funkcjonalnych (komunikacja, samodzielność, uczestnictwo); w szkole – modyfikacja w obszarach d1, d8 bez obniżania wymagań.
Metody i formy pracy	Metody wizualne i strukturalne (TEACCH, plany aktywności, piktogramy); nauczanie sytuacyjne; praca indywidualna i w parze przed pracą w grupie; modelowanie i wzmocnienia pozytywne.
Środki dydaktyczne	Karty pracy z jednym poleceniem i większą czcionką; pomoce manipulacyjne; tablet z aplikacją AAC; time-timer; nakładki ergonomiczne, nożyczki sprężynowe.
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć	Ocena wysiłku i postępu względem samego siebie; forma odpowiedzi do wyboru (wskazanie, obrazek, tablet); wydłużony czas; brak sprawdzianów bez zapowiedzi; w przedszkolu – obserwacja w naturalnych sytuacjach.
Tempo i czas pracy	Zadania krótsze, z przerwą sensoryczną po 8–10 min pracy; wydłużony czas na zadania pisemne i wykonawcze; brak przymusu dokończenia w tempie grupy.
Wymagania wobec zachowania	Jasne, wizualne zasady; ostrzeżenie przed zmianą; nauka komunikatu zastępczego zamiast karania; brak wymogu udziału w apelach w pełnym wymiarze (stopniowe wydłużanie).

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

B Dostosowania organizacyjne kształcenia

OBSZAR ORGANIZACJI	SPOSÓB DOSTOSOWANIA
Miejsce w sali	Ławka/stolik blisko nauczyciela, z dala od drzwi i okna; stały, oznaczony piktogramem; dostęp do strefy wyciszenia.
Organizacja dnia	Wizualny plan dnia; stałe rytuały rozpoczęcia i zakończenia; zapowiadane przejścia; przerwy sensoryczne 2–3 × dziennie.
Liczebność i skład grupy	Praca w małej grupie (3–5 osób) na zajęciach specjalistycznych; stały skład kadry; w miarę możliwości ta sama osoba wspierająca.
Wydarzenia i wyjścia	Udział w apelach i wyjściach po przygotowaniu (historyjka społeczna, zdjęcia); możliwość wcześniejszego wyjścia; opieka dodatkowej osoby.
Posiłki i samoobsługa	Stale miejsce przy stole; akceptacja wybiórczości pokarmowej z powolnym poszerzaniem; pasek wizualny czynności toaletowych.

C Nowe technologie wspierające dziecko / ucznia

OBSZAR	NARZĘDZIA I SPOSÓB WYKORZYSTANIA
Komunikacja (AAC)	Tablet z aplikacją komunikacyjną (symbole, syntezytor mowy) dostępny w sali i w domu; ta sama baza symboli w placówce i u rodziców.
Struktura i czas	Time-timer / aplikacja z wizualnym odliczaniem; cyfrowy plan dnia z odhaczaniem; przypomnienia dźwiękowe zamiast poleceń słownych.
Uczenie się	Materiały z obrazem i dźwiękiem; nagrane instrukcje do odtworzenia; aplikacje do ćwiczeń grafomotorycznych i emocji (rozpoznawanie mimiki).
Regulacja sensoryczna	Słuchawki wygłuszające; aplikacje z muzyką relaksacyjną / białym szumem w strefie wyciszenia.
Współpraca i monitoring	EduPlaner 2026 – wspólny zapis obserwacji i postępów; dziennik elektroniczny / aplikacja do kontaktu z rodzicami; rejestr ABC w formie cyfrowej.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

12 ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Wszystkie osoby pracujące z dzieckiem realizują te same cele w spójny sposób. Tabela pokazuje, kto co robi wobec wspólnego celu i jak działania są koordynowane:

WSPÓLNY CEL	NAUCZYCIEL / WYCHOWAWCA (CODZIENNIE W GRUPIE)	SPECJALIŚCI (ZAJĘCIA)	SPOSÓB KOORDYNACJI
Komunikacja funkcjonalna i AAC	Używa tablicy wyboru w każdej sytuacji; modeluje komunikaty; nie wymaga mowy tam, gdzie wystarczy wskazanie.	Logopeda: trening symboli i skryptów; pedagog specjalny: FCT w rewalidacji; psycholog: komunikacja emocji.	Wspólna baza symboli; miesięczny przegląd słownika AAC.
Regulacja emocji i zachowania	Stosuje protokół wyprzedzający; zapowiada zmiany; rejestruje ABC; nagradza komunikat zastępczy.	Psycholog: analiza ABC i plan wsparcia zachowania; terapeuta SI: dieta sensoryczna; pedagog: historyjki społeczne.	Jeden plan wsparcia zachowania dla wszystkich; przegląd rejestru ABC co miesiąc.
Uczestnictwo społeczne	Organizuje zabawy z rówieśnikiem-mentorem; wprowadza wizualne zasady grupy.	Psycholog: TUS w małej grupie; pedagog: ToM w rewalidacji.	Umiejętności z TUS ćwiczone w grupie w tym samym tygodniu.
Samodzielność i motoryka	Pasek wizualny czynności; dostosowane przybory; czas na samoobsługę.	Terapeuta pedagogiczny: motoryka mała; terapeuta SI: obronność dotykowa.	Ten sam pasek czynności w sali, na zajęciach i w domu.

Koordinacja. Koordynator Zespołu zwołuje spotkanie zespołu raz w miesiącu (30 min): przegląd celów, rejestru ABC, postępów w AAC; ustalenia zapisywane w EduPlaner 2026 i przekazywane rodzicom.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

13 ZAJĘCIA PRZYDZIELONE DZIECKU / UCZNIOWI I REALIZACJA ZALECEŃ PORADNI

Zajęcia zestawiono w podziale na rewalidację (kształcenie specjalne) i pomoc psychologiczno-pedagogiczną z dokładnym określeniem formy, czasu, okresu i miejsca udzielania. Blok C pokazuje, gdzie w programie realizowane jest każde zalecenie poradni. *Uwaga: godzina rewalidacji = 60 min; godzina zajęć PPP = 45 min (w przedszkolu czas dostosowany do możliwości dziecka).*

A · ZAJĘCIA REWALIDACYJNE · RAZEM

2 godz. = 120 min / tydz. · 3 rodzaje zajęć

B · POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA · RAZEM

3 godz. 30 min = 210 min / tydz. · 5 form pomocy**A Zajęcia rewalidacyjne przydzielone dziecku / uczniowi** · kształcenie specjalne · na podstawie orzeczenia

RODZAJ ZAJĘĆ	ZAKRES / CEL	PROWADZĄCY	FORMA	WYMIAR TYG.
Rewalidacja: rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i wdrażanie AAC	tablice wyboru, skrypty dialogowe, trening komunikacji funkcjonalnej (FCT)	Pedagog specjalny / neurologopeda	indywidualnie	1 × 60 min 60 min / tydz.
Rewalidacja: trening umiejętności społecznych i teorii umysłu (ToM)	rozpoznawanie emocji i intencji, historyjki społeczne, naprzemiennosc	Pedagog specjalny	indywidualnie / w parze	1 × 30 min 30 min / tydz.
Rewalidacja: usprawnianie motoryki małej i grafomotoryki	chwyt pisarski, koordynacja wzrokowo-ruchowa, planowanie ruchu	Terapeuta pedagogiczny	indywidualnie	1 × 30 min 30 min / tydz.
Razem zajęcia rewalidacyjne				2 godz. 120 min / tydz.

B Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej · forma · czas · termin · okres udzielania · miejsce

FORMA POMOCY	CEL	PROWADZĄCY	FORMA I MIEJSCE	CZAS I TERMIN	OKRES UDZIELANIA
Zajęcia logopedyczne	artykulacja, pragmatyka wypowiedzi, redukcja echolalii, dialog	Logopeda	indywidualnie · gabinet logopedyczny	1 × 45 min · wtorek 9:00	IX 2026 – VI 2027
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (TUS)	naprzemiennosc, radzenie sobie z przegraną, odczytywanie sygnałów rówieśników	Psycholog	grupa 3–5 osób · sala terapii	1 × 45 min · czwartek 11:00	IX 2026 – VI 2027
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	uwaga, pamięć, uogólnianie wiedzy, organizacja pracy	Terapeuta pedagogiczny	grupa do 5 osób · sala nr 4	1 × 45 min · poniedziałek 12:00	IX 2026 – VI 2027
Zajęcia specjalistyczne: integracja sensoryczna (SI)	modulacja sensoryczna, dieta sensoryczna, przerwy sensoryczne	Terapeuta SI	indywidualnie · sala SI	1 × 45 min · środa 10:00	IX 2026 – I 2027, po ocenie: kontynuacja
Porady i konsultacje dla rodziców	ujednoczenie oddziaływań dom–placówka, instruktaż AAC i ABC	Psycholog / koordynator	rodzice · gabinet lub online	1 × 30 min · piątek 15:00	cały rok szkolny
Razem pomoc psychologiczno-pedagogiczna					3 godz. 30 min 210 min / tydz.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

C Zalecenia poradni i miejsce ich realizacji w programie · każde zalecenie wskazuje sekcję, w której jest realizowane

Orzeczenie / opinia nr [Numer] z dnia [Data].

LP.	ZALECENIE PORADNI (Z ORZECZENIA / OPINII)	SPOSÓB REALIZACJI W PLACÓWCE	GDZIE W RAPORCIE	STATUS
1	Zajęcia rewalidacyjne 2 godz. tyg. (komunikacja, ToM, motoryka)	Blok A – rewalidacja	sekcja 13 A	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
2	Terapia logopedyczna z elementami AAC	Blok B – zajęcia logopedyczne; AAC także w sali i w domu	sekcje 13 B, 11 C	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
3	Terapia integracji sensorycznej i dieta sensoryczna	Blok B – SI; przerwy sensoryczne w organizacji dnia	sekcje 13 B, 11 B	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
4	Trening umiejętności społecznych w małej grupie	Blok B – TUS; ToM w rewalidacji	sekcje 13 B, 13 A	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
5	Wsparcie nauczyciela współorganizującego kształcenie	Uzasadnienie i zadania dodatkowej osoby	sekcja 14	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
6	Dostosowanie wymagań, metod i form pracy	Dostosowanie programu / podstawy i organizacji	sekcja 11 A–B	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
7	Stołość i przewidywalność otoczenia	Organizacja dnia, technologie (time-timer, plan cyfrowy)	sekcja 11 B–C	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane
8	Współpraca z rodzicami i ujednolicenie oddziaływań	Zakres współpracy, działania wspierające rodziców, poradnia	sekcja 15	☐ wdrożone ☐ w trakcie ☐ planowane

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

14 UZASADNIENIE WSPARCIA DODATKOWEJ OSOBY☒ **Nauczyciel współorganizujący kształcenie**☐ **Pomoc nauczyciela**☐ **Asystent / osoba wspierająca (za zgodą organu prowadzącego)**

WYMIAR I SYTUACJE

zajęcia kierowane, przejścia między aktywnościami, wydarzenia grupowe – ok. 20 godz. tygodniowo (zgodnie z arkuszem organizacji)

PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA

§ 7 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309); orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm.

UZASADNIENIE WYNIKAJĄCE Z OCENY FUNKCJONALNEJ

Wyniki oceny funkcjonalnej wskazują poziom wysoki potrzeby wsparcia w domenach d2 (zadania i wymagania), d7 (relacje) i d9 (uczestnictwo społeczne). Rejestr ABC wykazał 14 epizodów zachowań trudnych o funkcji ucieczkowej, wyzwalanych głównie w przejściach między aktywnościami i przy poleceniach wieloetapowych – czyli w sytuacjach, w których nauczyciel prowadzący grupę nie może udzielić natychmiastowego, indywidualnego wsparcia. Dziecko reaguje pozytywnie na stałego, przewidywalnego dorosłego (sekcja 4), a po wprowadzeniu wsparcia liczba epizodów spadła o ok. 40% (sekcja 8). Obecność dodatkowej osoby jest więc warunkiem bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach grupowych, a nie zastąpieniem aktywności dziecka.

ZADANIA DODATKOWEJ OSOBY

- ✓ Modelowanie użycia tablicy AAC i komunikatu zastępczego w sytuacjach trudnych.
- ✓ Uprzedzanie o zmianach i prowadzenie protokołu wyprzedzającego przed przejściami.
- ✓ Dekodowanie poleceń nauczyciela na pojedyncze kroki i piktogramy.
- ✓ Wsparcie w wydarzeniach grupowych (apele, wyjścia) z możliwością wycofania do strefy wyciszenia.
- ✓ Prowadzenie rejestru ABC i przekazywanie obserwacji Zespołowi.
- ✓ Stopniowe wycofywanie się z pomocy w czynnościach opanowanych (budowanie samodzielności).

Ocena zasadności. Zasadność wsparcia dodatkowej osoby oceniana w terminach z sekcji 16; kryterium zmniejszenia wymiaru: spadek epizodów ABC poniżej 3 miesięcznie i samodzielne przejścia między aktywnościami w 80% sytuacji.

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____

r.

15 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ**A Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami**

FORMA WSPÓŁPRACY	ZAKRES	ODPOWIEDZIALNY	CZĘSTOTLIWOŚĆ
Konsultacje indywidualne	omówienie postępów, rejestru ABC, planu tygodnia	Koordynator / psycholog	1 × / tydz. (piątek 15:00, 30 min)
Zeszyt korespondencji / aplikacja	codzienna informacja: co się udało, co było trudne, co ćwiczyć w domu	Wychowawca, dodatkowa osoba	codziennie
Udział w posiedzeniach Zespołu	opiniowanie programu, decyzje o poziomie wsparcia, ewaluacja	Dyrektor / koordynator	wrzesień, styczeń, czerwiec
Wgląd w dokumentację i wyniki	raport, IPET, arkusze obserwacji – kopia dla rodzica	Koordynator	na każde życzenie, po każdej ocenie
Obserwacja zajęć przez rodzica	udział w zajęciach rewalidacji / logopedii w celu przeniesienia metod do domu	Specjaliści	1 × / miesiąc

B Konkretnie działania nauczycieli i specjalistów wspierające rodziców

- ✓ Instruktaż użycia tablicy AAC w domu i przekazanie tej samej bazy symboli (logopeda).
- ✓ Pakiet piktogramów i wzór planu dnia na weekend oraz paska czynności toaletowych (wychowawca).
- ✓ Wskazówki postępowania w zachowaniach trudnych na podstawie analizy ABC – „co robić przed, w trakcie i po” (psycholog).
- ✓ Warsztat dla rodziców: regulacja sensoryczna w domu, dieta sensoryczna, przygotowanie do wyjść (terapeuta SI).
- ✓ Pomoc w przygotowaniu wniosków: aktualizacja orzeczenia, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, świadczenia (koordynator).
- ✓ Informacja o grupach wsparcia dla rodziców i ofercie PCTP; kontakt do specjalistów zewnętrznych za zgodą rodziców.

C Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami

DZIAŁANIE	ZAKRES / CEL	KTO	TERMIN
Przekazanie raportu oceny funkcjonalnej	zespół orzekający poradni – do wniosku o orzeczenie / aktualizację	Koordynator, za zgodą rodzica	po sporządzeniu raportu (wrzesień) i po ocenie końcoworocznej
Konsultacje specjalistyczne	wspólna analiza wyników, dobór metod AAC i wsparcia zachowania	Psycholog placówki ↔ psycholog poradni	1 × / semestr lub na wniosek
Obserwacja dziecka w placówce przez pracownika poradni	weryfikacja funkcjonowania w naturalnym środowisku	Poradnia, dyrektor	na wniosek rodzica lub Zespołu
Współpraca z lekarzem / terapeutami zewnętrznymi	ujednoczenie zaleceń (sen, farmakoterapia, terapia SI poza placówką)	Koordynator, za zgodą rodzica	w razie potrzeby
Instytucje wspierające rodzinę	PCPR, OPS, organizacje pozarządowe – informacja i pośrednictwo	Pedagog	w razie potrzeby

DOTYCZY DZIECKA _____

GRUPA / KLASA _____

DATA _____ r.

16 TERMINY OKRESOWEJ OCENY EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU

Ocena efektywności obejmuje cele z sekcji 9, wymiar zajęć (sekcja 13) i zasadność wsparcia dodatkowej osoby (sekcja 14). Rodzic uczestniczy w każdej ocenie i otrzymuje jej kopię.

TERMIN	ZAKRES OCENY	NARZĘDZIA	ODPOWIEDZIALNY	STATUS
Wrzesień 2026	Ocena wstępna i pogłębiona – niniejszy raport	KPOF/KSzOF, ABC, profil sensoryczny, mowa, ToM	Zespół, koordynator	wykonano
Na bieżąco (co miesiąc)	Monitoring: rejestr ABC, słownik AAC, postępy w celach	Rejestr ABC, karta postępów w EduPlaner 2026	Koordynator, dodatkowa osoba	w trakcie
Styczeń 2027	Ocena śródroczna (WOPF) – modyfikacja celów i wymiaru zajęć, decyzja o kontynuacji SI	KPOF/KSzOF (wybrane domeny), ABC, obserwacja	Zespół z udziałem rodzica	planowane
Czerwiec 2027	Ocena końcoworoczna – efektywność programu, wnioski do IPET na kolejny rok, ocena zasadności dodatkowej osoby	Pełny KPOF/KSzOF, arkusze, opinia rodzica i dziecka („Mój głos”)	Zespół z udziałem rodzica	planowane
Wrzesień 2027	Aktualizacja raportu oceny funkcjonalnej	zgodnie z § 7 ust. 6 i 7	Zespół	planowane

Informacja dla rodzica. Niniejszy raport stanowi opinię placówki o funkcjonowaniu dziecka i jest przekazywany rodzicowi oraz zespołowi orzekającemu poradni. Wyniki obserwacji służą zaplanowaniu wsparcia, a nie ocenie dziecka. Zachęcamy do rozmowy z Zespołem o każdej części dokumentu.

Koordynator Zespołu
podpis i data

Dyrektor placówki
podpis i data

Specjalista
podpis i data

Rodzic / opiekun prawny – zapoznałam/em się z raportem i uczestniczyłam/em w
ustaleniu poziomu wsparcia
podpis i data